

TEMA 4.2 • DERMATOLOGÍA

Psoriasis Vulgar

PERFIL EUNACOM 6.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Psoriasis Vulgar / Común

Es una patología inflamatoria crónica recrudesciente de la queratogénesis con una matriz fuertemente ligada a defectos de autoinmunidad basal y aceleración mitótica altísima de las células basales cutáneas que descaman prematuramente.

Cuadro Clínico Patognomónico y Morfología

- **Apariencia Básica:** Múltiples **Placas Eritemato-Descamativas** (lechos firmes rojos y secos sepultados por gruesas cáscaras platinadas y blancas ricas en escamas desprendibles nacaradas). - **Cartografía de Distribución:** Afecta clásicamente a las presiones de **Zonas Extensoras Mayores** bilaterales de los miembros en sus superficies osteocutáneas. - Mayor y recurrente afectación general en: Codos rudos, plano rotuliano de Rodillas, gran superficie dorsal de la Espalda baja, cara anterior en extremidades superiores netas y zona intraglútea. - **Diferencia Facial en Cuero Cabelludo:** Resalta su irrupción por fuera y que su invasión en placas costrosas **sobrepasan abundantemente la línea de implantación biológica folicular del pelo**, extendiendo sus escudos blancos secos más allá de las patillas, avanzando invasivamente por la frente libre o bajando hacia los márgenes posteriores del cuello. (Diferencial estricto contra la *Dermatitis Seborreica*, que sí se confina exclusivamente y respeta sus brotes a la cuenca grasa pilosa estricta). - **Micro Signología Ungueal Alterada:** Genera hoyuelos hundimientos minúsculos cráteriformes por defecto matricial en las uñas, conocidos clásicamente como el signo de los *Pits Ungueales* (**Signo del Dedal / Piqueteado de pájaros**).

Maniobra de Estimulación Diagnóstica: Raspado Metódico Clínico (Curetraje de Brocq)

Al frotar fuertemente o tallar intencional y progresivamente la superficie gruesa placa instalada cutánea (con material romo o la uña) emanan **3 Signos Fásicos sucesivos** patognomónicos confirmatorios: 1. **Fase I - Signo de la Mancha de Cera (Signo de la Vela):** Se desprende violentamente con extrema facilidad y profusión gruesas nubes en polvillo de cascajos y escamas sueltas nacaradas en caída seca simétrica. 2. **Fase II - Signo de la Última Película (Membrana Fina Cuticular de Duncan-Dulckley):** Una lámina plástica microscópica traslúcida elástica húmeda brilla adherida que opone breve tenacidad y finalmente se rasga separándose en bloque del epitelio basal al ejercer tensión. 3. **Fase III - Signo del Rocío Sangrante (Hemorragia Capilar Punteada de Auspitz):** Exposición aguda de los capilares y papilas microscópicas dérmicas desprotegidas descabezadas que exudan microgotas petequiales en llanto sanguinolento en el mismo lecho rosado denudado a ras.

Impacto Multisistémico Asociado

No asola limitándose solamente al espesor cutáneo estético. Se clasifica dentro de las **Espondiloartropatías Seronegativas factor reumatoide (-)** que disuelven entesis articulares distales profundas originando: - *Artritis Psoriásica* severa mutilante interfalangica y del gran esqueleto. - *Uveítis y Daño iridiocíclico anterior* crónico letal de ceguera.

Variantes Críticas Atópicas Agresivas de Alerta

1. **Forma Pustular Eruptiva:** Disminuyen las cáscaras secas escamosas, siendo recubiertas las cuencas por innumerables **Pústulas estériles inmensas diseminadas** masivamente, presentando altísima inestabilidad biológica para infecciones bacterianas fulminantes secundarias mortales. 2. **Variante de**

Flexura / Invertida Pura: Fenotipo raro. Se invierte su patrón geográfico perdiendo los codos y eludiendo rodillas, decantándose a destruir y recubrir los **Pliegues Internos Axilares, Inguinales abdominales, perianales e Interglúteos** asimilando candidiasis macizas crónicas. 3. **Crisis Eritrodérmica Letal (Eritrodermia Psoriásica Masiva):** Cuadro anárquico masivo fulminante y sistémico hospitalario que descama a carne viva **sobrepasa al 80% o el 90%** del territorio cutáneo epidérmico absoluto de manera roja y caliente disociando la termoregulación basal de extrema gravedad fatal de sobrevida.

Enfoque de Tratamiento Terapéutico y Farmacológico

- **Terapia Básica Inductora Leve o de Contacto:** El pilar irremplazable tópico desinflamatorio consta prioritariamente de **Corticoides Tópicos localizados**, amparados permanentemente en su eficacia curativa base por abundante baño emoliente ungüentos o vaselinas densas oclusivas humectantes continuas. Puede recambiarse a Inmunomoduladores tópicos libres atróficos (Ej. Inhibidores de la calcineurina celular dérmica paralelos como **Tacrolimus**). - **Terapéutica Ante Fallas y Formas Sistémicas Diseminadas o Severas Agresivas Inhabilitadas:** Cuando las cremas topográficas pierden cobertura se derivan hacia: 1. **Fase 1 General: Modulación Quirúrgica Fotodinámica Activa: PUVA-terapia** de gabinete controlada total. El bombardeo sistemático programable controlado por radiaciones de ráfagas fotolumínicas de **Luz Ultravioleta A combinada (UVA)**. 2. **Fase 2 de Escalamiento Oncológico-Inmunosupresor:** Uso potente interno de Inmunomoduladores sintéticos citostáticos puros (Ej: *Metotrexato*, *Ciclosporina celular u oral*) o en su cota altísima de terapia Blanco Biológico inhibiendo las citoquinas masivas promotoras directas (Ej: *Fármacos monoclonales Inhibidores de Bloqueo anti-TNF alfa de nueva generación destructivos de placas*).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Principio de Toxicidad Cutánea EUNACOM Vital: JAMÁS prescribir NINGÚN tipo de CORTICOIDE VÍA SISTÉMICA ORAL a gran escala crónico/agudo prednisona hacia una Psoriasis simple en un consultorio. ¿Por qué?: Posee un **MORTIFERO Riesgo de Efecto de Rebote Diseminado Masivo:** Su simple discontinuación o descenso genera el desencadenamiento incontrolable reactivado virótico a una Psoriasis Vulgar empujándola a que mute y corra súbitamente desestabilizada a enrostrarse y precipitar la grave y temida **Eritrodermia Psoriásica de Gravedad Sistémica Internación Hospitalaria**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Por qué están contraindicados los corticoides sistémicos en la psoriasis?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psoriasis Vulgar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La psoriasis produce placas eritematodescamativas en zonas extensoras como codos y rodillas.
- El cuero cabelludo está afectado y las lesiones sobrepasan típicamente la línea de implantación del cabello.
- El raspado de Brocq es patognomónico y produce signo de la vela, última película y rocío sangrante.
- Los pits ungueales son una manifestación importante y frecuente de la psoriasis.
- Las formas graves incluyen la psoriasis pustulosa generalizada y la eritrodérmica.
- Los corticoides sistémicos están absolutamente contraindicados por riesgo de rebote grave.
- El tratamiento severo incluye fototerapia PUVA con inmunomoduladores o agentes biológicos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSORIASIS VULGAR)**PREGUNTA 1**

¿Por qué están contraindicados los corticoides sistémicos en la psoriasis?

- A)** Porque causan hipertensión arterial severa e insuficiencia renal
- B)** Porque al suspenderlos pueden desencadenar un rebote grave de la enfermedad
- C)** Porque producen inmunosupresión que empeora el componente infeccioso
- D)** Porque interfieren con la fototerapia PUVA haciéndola ineficaz
- E)** Porque no tienen ningún efecto sobre las placas eritematodescamativas

PREGUNTA 2

¿Cuál es el signo patognomónico de la psoriasis que se produce al raspar metódicamente una placa?

- A)** El signo de Nikolsky con desprendimiento de epidermis
- B)** La aparición de vesículas con contenido seroso
- C)** El raspado de Brocq con signo de la vela, última película y rocío sangrante
- D)** La formación de cicatriz permanente después del raspado
- E)** La pigmentación residual con cambio de coloración permanente

PREGUNTA 3

¿Cuáles son las zonas de localización preferente de las placas en la psoriasis vulgar?

- A)** Zonas flexoras como axilas, ingles y pliegues submamarios
- B)** Palmas y plantas con afectación simétrica bilateral
- C)** Cara, especialmente mejillas y zona nasal perioral
- D)** Zonas extensoras como codos, rodillas, espalda y cuero cabelludo
- E)** Mucosas orales y genitales con placas blanquecinas

RESUMEN: PSORIASIS VULGAR

La psoriasis vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune que afecta aproximadamente al dos por ciento de la población mundial. Se caracteriza por placas eritematodescamativas con escamas blancas gruesas, localizadas preferentemente en zonas de extensión como codos, rodillas, espalda y cuero cabelludo, donde típicamente sobrepasa la línea de implantación del cabello. El raspado metódico de Brocq es patognomónico y produce tres signos sucesivos: primero el signo de la vela, luego la última película y finalmente el rocío sangrante. La afectación ungueal con pits o pozuelos es característica. Puede asociarse a artritis psoriásica, uveítis y síndrome metabólico. Las formas graves incluyen la psoriasis pustulosa generalizada y la eritrodérmica. El tratamiento de la enfermedad leve incluye corticoides tópicos y emolientes. La enfermedad severa requiere fototerapia PUVA más inmunomoduladores o agentes biológicos. Los corticoides sistémicos están contraindicados porque pueden desencadenar un rebote grave al suspenderlos.